PÓS-GRADUAÇÃO EM CIÊNCIAS DO ESPORTE APLICADAS À SAÚDE

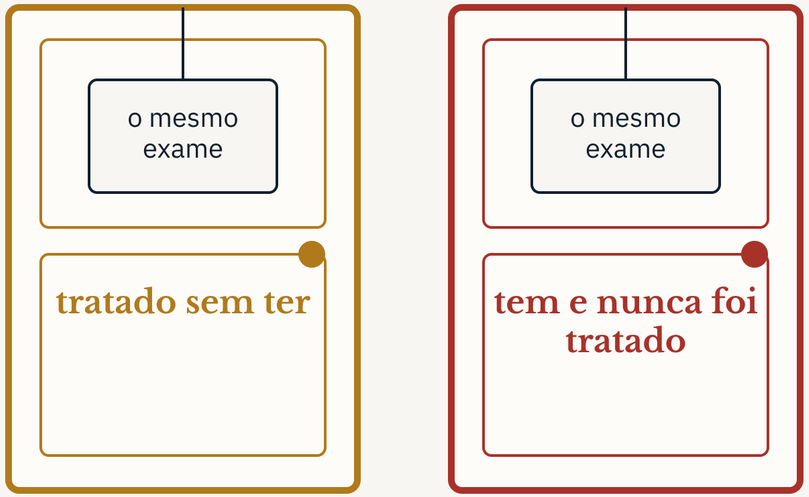
Hipogonadismo masculino

Diagnóstico diferencial e armadilhas de interpretação

Fisiologia Hormonal e Endocrinologia do Exercício

DOIS ERROS SIMÉTRICOS

Tratado sem ter, ou tem e nunca foi tratado



1 em 650

nascimentos masculinos com síndrome de Klinefelter

3 em 4

dos afetados nunca diagnosticados

E eles passam pelo consultório por infertilidade, ginecomastia, dificuldade de ganhar massa: as queixas que chegam à nossa área.

Bojesen, Juul e Gravholt, Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism 2003 · registro nacional da Dinamarca

PASSO UM

Classificar em três caixas

Primário

LH e FSH altos

Klinefelter
criptorquidia
trauma, torção, orquite
quimio, radioterapia

Central orgânico

LH e FSH baixos ou normais

tumor de hipófise
prolactina alta
hemocromatose
Kallmann, trauma craniano

Funcional

LH e FSH baixos ou normais

pouca energia, sono curto
obesidade
treino sem recuperação
remédios, anabolizante

mesmo exame: quem separa é a história e o exame físico

PASSO DOIS

Auditar como o número foi produzido

Horário
coleta de tarde é coleta no vale

Alimento
depois de comer, o valor cai por horas

Doença aguda
o exame descreve a virose, não o eixo



Treino recente
a manhã seguinte à sessão pesada não é base

SHBG não pedida
atleta magro e obeso erram em sentidos opostos

Troca de método
laboratórios diferentes, “queda” de método

Qualquer uma comprometida: repita, não trate.

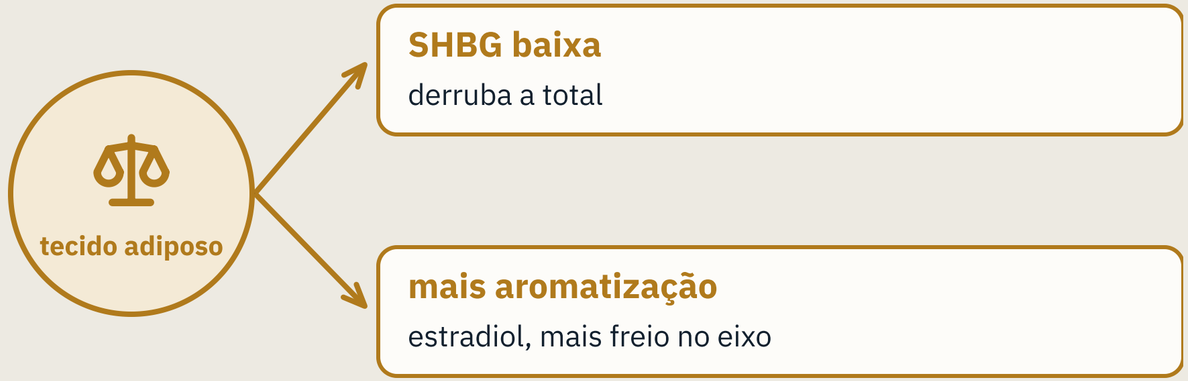
AS MAIS ACIONÁVEIS

Remédios e obesidade

Remédios que suprimem o eixo

- opioide, inclusive o crônico para dor
- corticoide em dose alta ou prolongada
- antipsicóticos e alguns antieméticos: prolactina
- gabapentinoides, antiandrogênicos

Obesidade, por duas vias



perder peso sobe a testosterona: a causa reversível mais comum

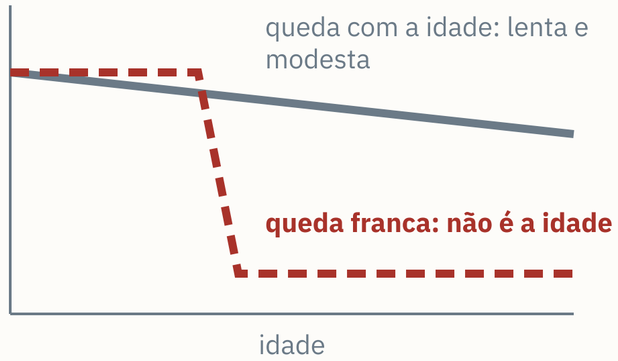
Perda de peso é intervenção de primeira linha sobre o próprio eixo: sem ampola, sem supressão, sem impacto na fertilidade.

Corona e colaboradores, European Journal of Endocrinology 2013 · Bhasin e colaboradores, Endocrine Society 2018

PASSO TRÊS

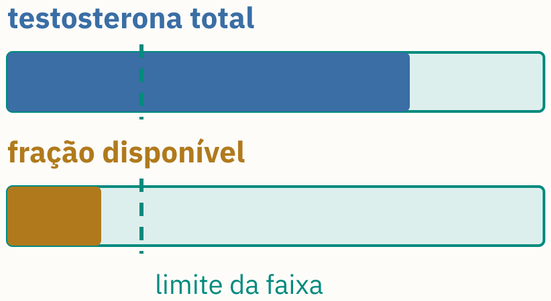
As armadilhas que escondem o hipogonádico

“É normal nessa idade”



a idade não explica um valor muito baixo

Total normal com SHBG alta



o magro de endurance passa, com fração disponível ruim

Prolactina não pedida

- [x] Testosterona total
- [x] LH e FSH
- [x] SHBG
- [ ] **Prolactina**

em todo padrão central; ferro quando a história sugerir

Esquemas, sem valores medidos

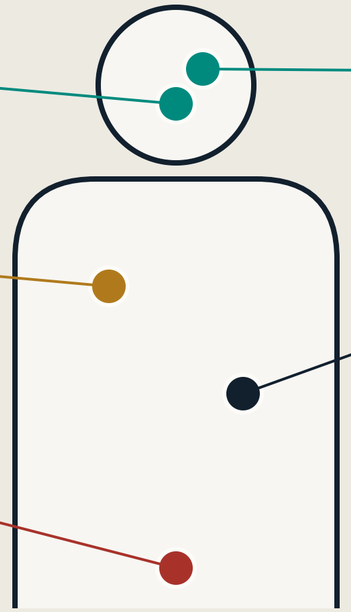
A ARMADILHA QUE MAIS FALTA

O exame físico que decide

Olfato
Kallmann: “sente cheiro normalmente?”

Mama
glândula à palpação, não gordura

Volume testicular
pequenos e firmes: primário · pequenos e moles: supressão central longa

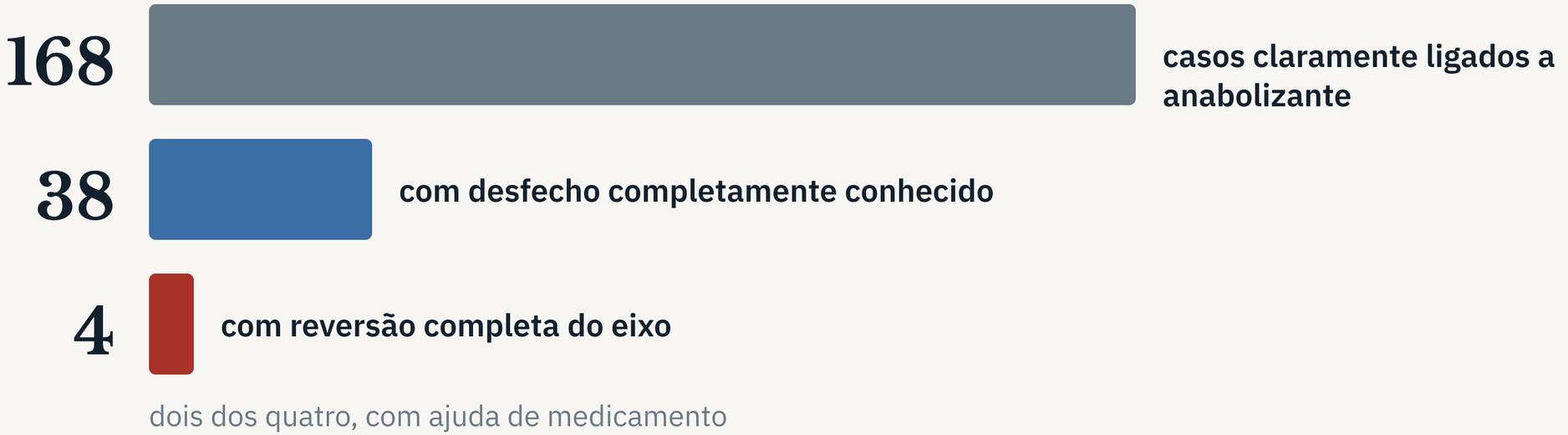


Campo visual
30 segundos: compressão do quiasma

Pelos e puberdade
antes ou depois da puberdade

UMA REVISÃO DE 2021

Mais do que se promete, e nem sempre volta



dois dos quatro, com ajuda de medicamento

Viés: relato publicado favorece o caso que deu errado. Mas ninguém consegue prometer quanto tempo, nem se.

Vilar Neto e colaboradores, Andrologia 2021 · Solanki e colaboradores, Endocrine Connections 2023

SEM MORALISMO

Três coisas ditas com clareza

“Ciclo” sugere um retorno que não é garantido

Terapia pós-ciclo não é botão de reset

é conduta médica, com indicação, e não garante retorno

Fertilidade se discute antes

não depois de três anos de uso

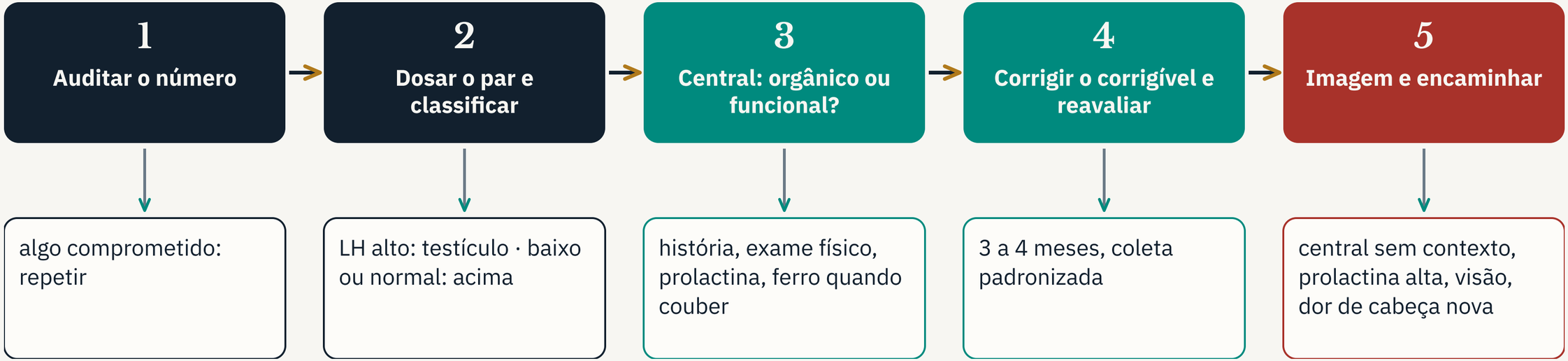
Pergunte, pelo nome

- **qual substância**
- **por quanto tempo**
- **há quanto tempo parou**

Testosterona baixa, LH baixo, testículos pequenos e moles: é aqui que a pergunta entra.

O PROCEDIMENTO

Cinco passos, cada um com sua saída



QUEM FAZ O QUÊ

Tratar a causa, e não o número

- ✓ Idade não é diagnóstico
- ✓ Classificar, investigar e tratar é ato médico

O padrão clínico

Quem atende toda semana vê rendimento, humor e massa caindo apesar do treino.

A substância

Contada ao educador físico, chega ao médico com o consentimento do paciente.

Não é delação. É a diferença entre tratar a causa e tratar o número.